2.1.3 환자진료의 일관성 및 연속성 유지			
규 정 번 호	2.1.3	제 정 일	3주기 규정집 제정
관련 인증기준	2.1.3 환자진료의 일관성 및 연속성 유지	최근 개정일	2025-10-15
담 당 부 서	진료부, 간호부, 원무과	시 행 일	2025-11-01
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	2027-10-15
관 련 근 거			

▣ 목적 (Purpose)

의료기관은 진료의 일관성 및 연속성을 유지하기 위하여 전반적인 진료 또는 특정 진료에 대한 책임자를 정하고, 환자의 문제를 해결하기 위해 일관된 절차에 따라 진료를 제공하고 표준화된 의사소통 과정을 통해 정보를 공유하여야 한다.

▣ 용어의 정의 (Definition)

- 담당 주치의 변경 : 진료과 – 진료과 간의 이동, 진료과 내 담당의사 변경
- 전동 : 병동 – 병동 간의 이동
- 근무 교대 : 의사의 당직 근무 교대 시, 간호사 근무 교대 시

▣ 정책 (Policy)

1. 환자 책임의사 지정 및 담당 의료진 변경 시 정보공유에 대한 규정이 있다.
2. 전과 시 의무기록을 작성하여 환자 상태에 대한 정보를 공유한다.
3. 전동 시 의무기록을 작성하여 환자 상태에 대한 정보를 공유한다.
4. 근무교대 시 환자 상태에 대한 정보를 공유한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 환자 진료를 책임지는 의사 지정

가. 환자 진료를 책임지는 의사 지정 절차

1) 외래 진료 일정에 따라 환자 및 보호자의 결정을 우선순위로 한다.
2) 환자 및 보호자가 책임의사 지정이 없을 시 원무과 직원은 관련 진료과목에 맞게 지정하거나 해당 과목이 없을 경우 유사한 진료과목으로 지정한다.

나. 환자의 전반적인 진료 또는 특정 진료단계의 책임의사의 역할 및 책임

1) 책임의사는 환자의 전반적인 책임을 지며 필요 시 타 분야의 전문가의 의견을 조율하여 진료의 일관성 및 연속성을 유지 하여야 한다.

다. 책임 의사에 대한 정보 공유 (변경되는 경우 포함)

1) 입원 시 담당간호사는 전자의무기록(EMR)을 통해 책임 의사에 대한 정보를 공유 받으며 환자에게 입원 생활안내 시 책임의사에 대해 정보(의사의 성명, 회진시간 등)를 제공한다.
2) 입원 중 책임의사가 변경되는 경우 변경 전 책임의사는 환자 및 보호자에게 변경 사유를 설명하고 담당 간호사는 변경 후 책임의사에 대한 정보(의사의 성명, 회진시간 등)을 공유한다.

3) 전자의무기록(EMR)을 통해 책임의사에 대한 정보를 관련 직원과 공유한다.

2. 환자 담당 의료진 변경

가. 전과(동일 진료과 내 책임의사 변경 포함)

1) 환자의 요구도에 맞는 적절한 진료의 연속성을 보장하기 위해 환자 전과 시 전과를 받는 과와 보내는 과 간의 상세한 의무기록(전과기록지)으로 필요한 정보를 공유한다.
2) 전과의 지시는 각 과 담당의사에 의해서만 이루어진다.
3) 담당의사는 환자와 보호자에게 전과에 대한 충분한 설명을 제공하여야 한다.
4) 담당의사 변경 시 정보공유
   가) 환자의 기본정보
   나) 투약력 및 검사결과
   다) 인계시점에서의 환자 상태 및 치료경과
   라) 향후 치료계획
5) 의무기록 작성 시기 : 담당의사 변경 시점을 기준으로 24시간 이내 전과기록지에 작성한다.
6) 담당의사 변경이 결정되면 원무과에 알린다.

나. 전동

1) 전동이 이루어지는 상황 : 환자가 원할 경우, 환자의 상태를 고려하여 담당의사의 전동요청이 있는 환자, 격리/역격리 환자의 1인용 이동 등 환자의 진료 요구에 따른 전동
2) 전동이 결정되면 의료진은 먼저 환자와 보호자에게 전동사유에 대해 설명한 후 카덱스와 EMR(전동기록지 등)을 통해 인수인계한다.
3) 전동 시 정보공유
   가) 환자의 기본 정보
   나) 환자 상태
   다) 필요시 제공 되는(제공되어야 하는) 장비 및 기구(보조기, 기관절개관, 흡인기 등)
   라) 의료진의 동반 여부
4) 의무기록 작성 시기 : 병동 변경 시점을 기준으로 24시간 전 전동기록지에 작성한다.
5) 전동이 결정되면 전동 전 병동에서 원무과에 알린다.

다. 전동 시 의료진의 동반이 요구되는 상태

1) 인공호흡이 필요한 환자
2) 쇼크(Shock)가 동반된 환자
3) 기도폐쇄, 심한 출혈 등이 있는 환자
4) 활력 징후가 정상 범위를 크게 벗어나 이를 유지하기 위해 이동 중에도 의료진의 도움이나 즉각적인 처치가 필요한 경우

3. 근무 교대

1) 담당의사와 당직의사의 근무 교대 시 환자 상태에 대한 정보를 공유한다.
   가) 담당의사는 당직의사에게 당직일지로 환자 상태를 인계하거나 추가 정보 전달이 필요한 경우 전자의무기록(EMR)을 활용한다.
   나) 당직의사는 담당의사에게 당직일지로 환자상태를 인계한다.
2) 간호사는 근무 교대 시 전자의무기록(EMR)을 이용하여 다음 번 근무 간호사에게 환자 상태에 대한 정

보를 인수인계한다.

가) 입원환자, 퇴원환자, 처방, 검사, 처치 및 환자의 특이사항에 대해 인수인계한다.

▣ **부록 (Appendix)**

1. 의사 당직일지
2. 전과기록지
3. 전동간호기록지

▣ 규정 개정일 [누적]

2025년 10월 15일 개정하고 2025년 11월 1일 시행한다.

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일					

의사 당직일지

당직의사: (서명) 병원장: (서명)

202 년 월 일 요일

1. 주치의 인계사항					
진료과	호실	환자명	등록번호	내용	서명

2. 당직의 인계사항				
분류	호실	환자명	등록번호	내용
응급전원				
CPR				
기타				

부록2. 전과 기록지

전과 기록지

차트번호		성 명		성별/나이	/
진 료 과		병 실			

<Transfer Out Note>

1) Impression (진단명)
2) Present Illness (환자상태에 대한 임상적 소견 및 전과 이유)
3) 투약력 및 검사결과
4) Problem List & Plan (문제목록과 향후 치료계획)
년 월 일 시 분 DR : (인)

<Transfer In Note>

1) Impression (진단명)
2) Present Illness (환자상태에 대한 임상적 소견 및 전과 이유)
3) 투약력 및 검사결과
4) Problem List & Plan (문제목록과 향후 치료계획)
년 월 일 시 분 DR : (인)

부록3. 전동 간호 기록지

전동간호기록지

등록번호		환자명		성별/나이	/
입 원 일	년 월 일				
전 동 일	년 월 21 일				
	전동전		전동후		
병 동					
호 실					
전동사유	□ 집중치료 및 간호 □기타				
환자상태	□ 명료 □ 혼돈 □ 반혼수 □ 혼수 □ 기타				
낙상위험 사정군	□ 저위험군 □ 고위험군 □개인간병 고려대상				
욕창위험 사정군	□ 위험없음 □ 저위험군 □ 중위험군 □고위험군 □ 최고위험군				
식 이	□ 일반식 □ 당뇨식 □ 죽 □ 미음 □ 금식 □ 관급식 N-G 삽입일( ) □ 기타				
배 설	□ 자연배뇨 □ 기저귀 □ Foley cath 삽입일 ( ) □ 기타 ( )				
물 품	□ 챠트 □ 카덱스 □ X-ray □ CD 장 □ 틀니 □ 기타 ( )				
보 낼 약	경구약 □유 □무 (day)	지참약 □유 □무(day)		주사제 □유 □무	
투약내용					
정서상태	□ 안정 □ 불안정 □ 분노 □ 슬픔 □ 우울 □ 기타 ( )				
수면장애 여 부	□ 잘잔다 □ 자기 힘들다 □ 극도로 불면 □ 기타				
의료진동반 여 부	□ 의사 □ 간호사 □ 간병사 □ 기타 ( )				
필요장비	□O2 □Suction □EKG monitoring □기타:				
알레르기	□ 있음 (약물,음식 기타) □ 없음				
수술경험	□ 있음 □ 없음				
기 타					
보낸간호사	(서명)	받는 간호사		(서명)	